Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de São Marcos

Rua Carlos Gomes, 557 - Bairro: Centro - CEP: 95190000 - Fone: (54) 3022-9848 - Balcão Virtual: (54) 99681-3606 - Email: frsaomarcvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001996-87.2023.8.21.0128/RS

AUTOR: SUELI TERESINHA VALDEZ

RÉU: UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos.

SUELI TERESINHA VALDEZ ajuizou "Ação Condenatória com pedido de tutela de urgência" em desfavor de **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.** A autora noticiou que foi diagnosticada com neoplasia maligna de ovário em estágio avançado, CID10 C56. A Autora apresenta mutação germinativa em gene BRCA1, o que lhe confere chance considerável de resposta positiva a inibidores PARP. Mencionou ter realizados outras alternativas de tratamento, contudo sem o efeito esperado. Narrou que é beneficiária do plano RB68 BÁSICO da Ré. Disse que seu médico assistente prescreveu o uso da medicação Lynparza 150MG, 02 cápsulas a cada 12 horas. Contou que a requerida não autorizou o fornecimento da medicação prescrita. Requereu a concessão da medicação em tutela provisória de urgência. Requereu AJG. Juntou documentos. (evento 1, INIC1)

Recebida a inicial, deferido o benefício da AJG. Foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência**,** para determinar que a ré forneça o medicamento requisitado pelo médico e descrito na inicial Lynparza 150mg, via oral, 04 cápsulas ao dia, continuamente, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em 30 dias (evento 3, DESPADEC1).

Remetidos os autos ao CEJUSC, realizaram sessão de mediação cível, entretanto, não chegaram a um entendimento. (evento 22, TERMOAUD1)

Citada, a ré contestou, justificando a negativa de cobertura do referido medicamento na Diretriz de Utilização (DUT) nº 64 da Resolução Normativa da ANS, que regula a cobertura obrigatória de terapias antineoplásicas orais. Ressaltou que o medicamento solicitado não se enquadra no rol de procedimentos da ANS para a patologia da autora e não há comprovação de sua eficácia conforme a medicina baseada em evidências. Argumentou que, conforme a legislação vigente, a cobertura obrigatória de tratamentos fora do rol da ANS requer comprovação de eficácia científica, recomendação pela Conitec ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, o que não se verifica no caso do *"Olaparibe"* para a condição específica da autora. Alegou, ainda, que a negativa de cobertura se deu com base em critérios técnicos e contratuais, e que a Unimed esclarece aos seus contratantes que os serviços contratados são referenciados no Rol da ANS, descaracterizando, assim, qualquer arbitrariedade na negativa de cobertura do medicamento. Pugnou pela improcedência dos pedidos (evento 26, CONT1).

Houve réplica (evento 29, RÉPLICA1).

Instadas, as partes não manifestaram interesse na produção de provas (evento 30, DESPADEC1), as partes requereram o julgamento do feito no estado em que se encontra (evento 34, PET1 e evento 35, PET1).

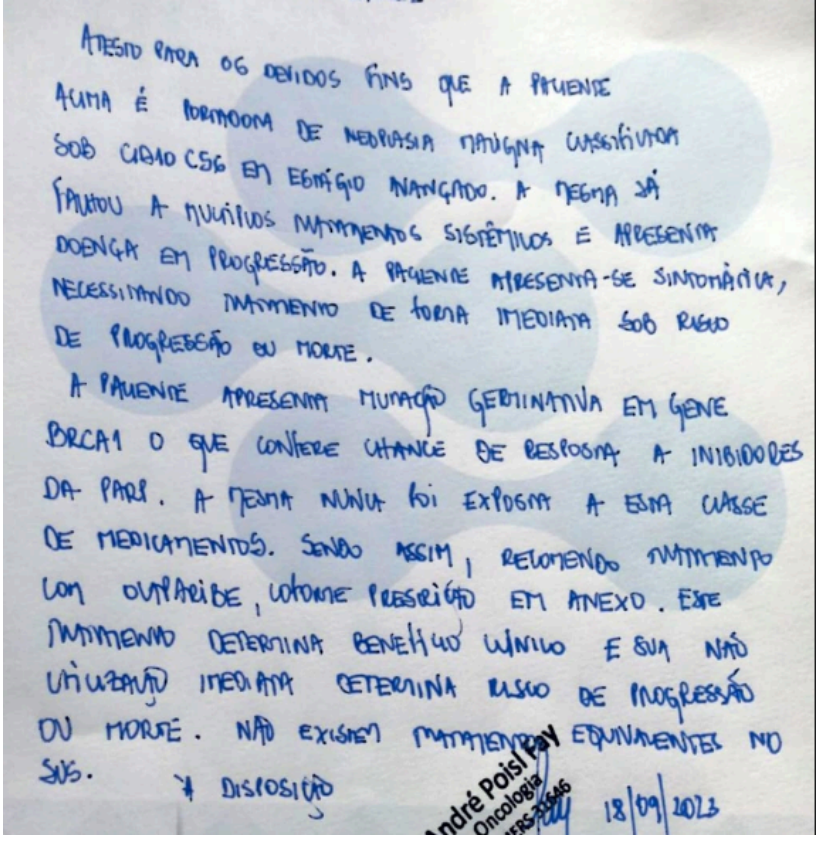
Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo questões pendentes ou vícios a serem sanados ou mesmo necessidade de produção de provas em audiência, cabível o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC.

Trata-se de ação, em que a parte autora postulou o deferimento de liminar, de modo a obrigar a ré a fornecer o medicamento requisitado pelo médico e descrito na inicial: ***Lynparza*** *(Olaparibe)* 150mg, via oral, 02 cápsulas, 2x ao dia, continuamente. Não há controvérsia acerca da contratação do plano de saúde, tampouco da negativa da ré em fornecer o medicamento extrajudicialmente, assim como de ser a autora portadora da moléstia mencionada, sendo que, segundo o médico responsável pelo tratamento (evento 1, LAUDO5):



Atesto para os devidos fins que a paciente acima é portadora de neoplasia maligna confirmada sob CID10 C56 em estágio avançado. A mesma já apresentou a múltiplos tratamentos sistêmicos e apresenta doença em progressão. A paciente apresenta-se sintomática, necessitando tratamento de forma imediata sob risco de progressão ou morte.

A paciente apresenta mutação germinativa em gene BRCA1 o que confere chance de resposta a inibidores da PARP. A mesma nunca foi exposta a essa classe de medicamentos. Sendo assim, recomendo tratamento com olaparibe, conforme prescrição em anexo. Este tratamento determina benefício clínico e sua não utilização imediata determina risco de progressão ou morte. Não existem tratamentos equivalentes no SUS.

À disposição

André Poisl Pay
Oncologia
CRM-RS 30546

18/09/2023

Cinge-se a controvérsia, portanto, sobre a possibilidade de negativa quanto à cobertura do medicamento que necessita a autora, ao argumento de que o fármaco solicitado não se enquadra no rol de procedimentos da ANS para a patologia da autora.

Inicialmente, destaca-se que o caso deve ser apreciado levando-se em conta o disposto no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor:

> *Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.*
>
> *§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.*
>
> *§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.*

A questão resta pacificada na Súmula nº 469 do STJ**:**

> *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.".*

Assim como na Súmula nº 608 do STJ:

> *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".*

No caso em apreço, a Unimed justificou a negativa de cobertura com base na Diretriz de Utilização Técnica nº 64 da ANS, a qual regula o fornecimento de terapias antineoplásicas orais para tratamento do câncer, dispondo de um rol de substâncias ativas cobertas e de um rol de indicações de uso, sendo obrigatória somente a cobertura dos medicamentos listados para as indicações de uso ali constantes, sendo que o medicamento *Olaparibe (Lynparza)* 150mg solicitado pela autora não está enquadrado na referida Diretriz.

Ressalto, de plano, que a justificativa apresentada pela Unimed não comporta acolhimento. Embora não se desconheça a existência da Resolução estabelecendo critérios objetivos para a cobertura, não se pode esquecer que a medicina não é uma ciência exata, possuindo cada caso clínico as suas peculiaridades e necessidades.

Com efeito, incumbe ao médico estabelecer qual o melhor tratamento a ser prescrito, de acordo com as peculiaridades da patologia de cada paciente, não sendo dado à operadora do plano de saúde negar a cobertura com base em rol exemplificativo e genérico.

No caso em apreço, resta comprovado que o tratamento postulado se mostrava imprescindível para o tratamento da doença que acometeu a consumidora, conforme documentos acostados à inicial, em especial o laudo médico, cujo trecho está colacionado nesta decisão, que evidencia a gravidade da doença e ressalta que o tratamento com o medicamento requerido diminui, de forma expressiva, a taxa de recorrência da doença e de mortalidade.

Nestes termos, mostra-se inadmissível que a requerida tenha se contraposto à cobertura ao tratamento prescrito à autora, indispensável para o tratamento da doença que lhe acometia. Ademais, considerando a imprescindibilidade do tratamento naquela época, deve prevalecer a cobertura contratual de modo genérico, sob pena de se considerar abusiva a cláusula contratual vedativa ou sua interpretação restritiva, à luz do artigo 54 do CDC.

Além disso, a tese de ausência de cobertura por falta de previsão no rol da ANS não prospera, haja vista ter sido superada pelo STJ, que apregoou a impossibilidade de limitação de cobertura de tratamentos neoplásicos orais, sendo indiferente a existência de previsão no rol da agência reguladora, dada as características específicas de elaboração da listagem para tais medicamentos.

Nessa senda:

> *CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PET-CT OU PET-SCAN. PRESCRITO POR MÉDICO.* ***DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA****. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.*
> *1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)*
> *serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.*
> *2.* ***Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.***
> *3. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo.* ***Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt no REsp 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).*** *4. A Corte Especial do STJ reafirmou ser indevido limitar a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.956.632/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) Grifei.*

Ademais, depois da vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de negar a cobertura ao tratamento indispensável à parte autora. Existe dever do prestador de serviços de plano de saúde de cobrir, de forma ampla, todos os procedimentos, medicamentos e intervenções úteis ou necessárias à manutenção da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças.

No caso dos autos, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa n.º 465/2021 da ANS, a qual não pode excluir ou mitigar as hipóteses previstas na Lei dos Planos de Saúde:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,* ***respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:***
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*
>
> *Transcreve-se o mencionado art. 12, grifando-se na parte em que se aplica à situação examinada:*
>
> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *[...]*
>
> *c)* ***cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;***
>
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
>
> *(...)*
>
> *g)* ***cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral****, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;*

Somado a isso, com relação a taxatividade do Rol de Procedimentos publicado pela ANS, deve ser levado em consideração que a Lei nº 9.656/98 foi alterada pela Lei nº 14.454/2022, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios, conforme segue:

> *Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.*
>
> *Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:*
>
> *"Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). (...)*

*4º A **amplitude das coberturas** no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, **será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar,** atualizado a cada incorporação.*

*§ 12. **O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica** para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*

*§ 13. **Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde**, desde que:*

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;

Nesse sentido, corroborando o acima exposto, de que o rol de critérios para a cobertura de procedimentos/medicamentos previstos pela ANS é apenas exemplificativo, cabendo ao médico estabelecer qual o procedimento mais adequado ao caso, são os julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Superior Tribunal de Justiça:

*CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO **CÂNCER**. **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA**. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. **Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.** Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.057.814/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).*

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAZOPANIBE (VOTRIENT). NEOPLASIA MALIGNA TIPO LEIOMIOSSARCOMA DE ORIGEM UTERINA COM RECIDIVADA EM PULMÕES E ABDÔMEN. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO VERIFICADOS. NO CASO CONCRETO, DEMONSTRADO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, TENDO EM VISTA O RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. **DESCABIDA A NEGATIVA DE FORNECIMENTO, POIS INCUMBE AO MÉDICO PRESCREVER O TRATAMENTO. DIREITO AMPARADO NO ART. 12, I, "C", DA LEI N° 9.656/98 QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL COMO PROCEDIMENTO DE COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA PELOS PLANOS DE SAÚDE**. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50288633120248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 24-04-2024)*

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PACIENTE COM CÂNCER DE RIM. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. Obrigação de fazer. Fornecimento dos medicamentos PEMBROLIZUMABE e AXITINIBE. Tratamento de câncer de rim. Em regra, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é taxativo, não podendo ser exigidos das operadoras de plano de saúde, portanto, a cobertura dos tratamentos ali não previstos. **Entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, no entanto, admite mitigações, sobretudo após alterações da Lei nº 14.454/2022. Caso dos autos em que o autor foi diagnosticado com "Câncer de rim, Cid c64", razão pela qual necessita fazer uso do tratamento combinado dos medicamentos PEMBROLIZUMABE e AXITINIBE. Com efeito, o artigo 12 da Lei nº 9.656/98 elencou os medicamentos antineoplásicos dentre as coberturas obrigatórias, ainda que para tratamento domiciliar. Tampouco a alegação de que a negativa de cobertura teve por fundamento o uso off label (sem previsão de utilização específica em bula do medicamento) merece prosperar, uma vez que é considerada abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label). Entendimento do STJ.** Assim, é devido o fornecimento do medicamento. **(...)** Precedentes desta Câmara. Sentença de parcial procedência mantida. Honorários advocatícios. Recurso que vai parcialmente provido, a fim de majorar os honorários fixados na origem, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, por apreciação equitativa. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ UNIMED E DERAL PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOA UTOR, A FIM DE MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (Apelação Cível, Nº 50249805820238210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-04-2024) .*

Ademais, é entendimento do STJ que os planos de saúde podem estabelecer quais as doenças que receberão cobertura, mas não o tipo de tratamento, o qual é de competência do médico que acompanha o paciente, consoante se extrai do voto do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito:

*"A orientação que se vem firmando, e que merece exame da Corte, é sobre esse ponto, considerando a consolidação legislativa vigente com a Lei n° 9.656/98. O que se procurou fazer, pelo menos no meu entender, foi estabelecer critério para proteger o consumidor e ao mesmo tempo assegurar a viabilidade empresarial dos planos privados de saúde. **De fato, não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido. Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor.** Foi nessa linha que esta Terceira Turma caminhou quando existia limite de internação em unidade de terapia intensiva (REsp n° 158.728/RJ, da minha relatoria, DJ de 17/5/99), reiterado pela Segunda Seção (REsp n° 251.024/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 4/2/02)".*

Destarte, era dever da demandada fornecer o tratamento pleiteado, sem a necessidade de intervenção judicial, sendo a procedência do pedido medida que se impõe.

DIANTE DO EXPOSTO, e para fins do art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **SUELI TERESINHA VALDEZ** em face de **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA** para tornar definitiva a tutela liminar de urgência (evento 3, DESPADEC1),

determinando à demandada que forneça o medicamento requisitado pelo médico: Lynparza (Olaparibe) 150mg, via oral, 04 cápsulas ao dia, continuamente, enquanto necessário ao tratamento.

Sucumbente, arcará a ré com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 85, § 8°,do CPC.

Publicada, registrada e intimadas as partes via sistema.

Interposto(s) recurso(s) de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) apelada(s) para, em quinze dias, apresentar(em) contrarrazões. Caso haja recurso adesivo ou suscitação de questões preliminares (artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil) em contrarrazões, dê-se vista ao(s) apelante(s) por novos quinze dias, para manifestação.

Concluídas as intimações e decorridos os prazos, remeta-se o feito ao E.Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se pelo lançamento do correspondente movimento no sistema Eproc.

Verifiquem-se as custas finais.

Após, nada mais sendo requerido, e não subsistindo pendências, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO CURVELLO MARTINS DE SOUZA, Juiz de Direito**, em 30/05/2025, às 17:47:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10082997732v5** e o código CRC **17355c5f**.